جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : صفاء حماده محمد حسانين
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** البدرشين **العنوان :** دهشور
رقم البطاقة : 28412222101621 **رقم التليفون :** 01145431591 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 22-12-1984 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: صفاء حماده محمد حسانين
National ID: 28412222101621

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



صفاء

حماده محمد حسانين

زاوية دهشور

مركز البدرشين - الجيزه

٢٨٤ ١٢ ٢٢ ٢١ ٠١٦ ٢١

KU8054625



٢٨٤١٢٢٢٢١٠١٦٢١ ٢٠٢٤/١٠

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة

رضا عبدالباسط مبروك حسانين

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٠/١٨



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : شفاء حماد محمد حسانين
Sex: Female
3- Medical number: 83155241
Old Med :
2801-2023

2-ID number: 28412222101621
Patient Age : 39 Y

Family history
Phone 01145431591 01101640586
BMI
REASON OF MDT

marital status
NRS Score
GROUP
Date of MDT 2023-10-15

Co morbidity free
Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
CTCAP-->INTERSTITIAL PULMONARY REACTION
REST UNREMARKABLE

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :
OTHER MIXED DUCTAL AND LOBULAR	8/8	7/8	0		20

T	N	M
WLE(PT2 TWO FOCI	1	0

Sonomammography
EXCSIONAL BX: ILC

PATIENT HISTORY
CESM7/9/2023:lt breast : pre contrast: ill-defined mass at UOQ about 4 cm from the nipple post contrast: the previously described UOQ mass showed heterogeneous contrast uptake measure 19 x 13 x15 mm & pre areolar thickened enhancing skin & axillary LN level 1 with maximum cortical thickness 4 mm
rt breast: no dominant mass lesion
IT MRM:
free margins
free LNs

MDT OUTCOME & PLAN

THE CASE IS PT2(BI-FOCAL) N0/12 M0.FOR FULL LABS AND ECHO THEN ADJUVANT ACX4 THEN TAXOTERE X4 THEN PORT THEN TAMOXIFEN +ZOLADEX FOR 2 YEARS THEN SHIFT TO AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	13/10/2023	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	

Patient Name	: الأستاذه / صفاء حماده محمد حسانين	Request No.	: 13000161
Patient No.	: 28412222101621	Request Date	: 13/07/2023
Path No.	: SR-783/23	Verification Date	: 31/07/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 38 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Slide Revision.

Gross Examination:
- Four slides labeled by (8366) were received.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+ 1).
* DCIS: Present.
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.

Diagnosis:
Right breast mass, Slide revision:
Invasive duct carcinoma GII .
Case for IPT (ER, PR, Her2, KI67)

Comment: Slides are badly stained . Blocks are needed for proper diagnosis and performing immunophenotyping.

Prof. Dr. Gamal Abdelaty. Dr. Marwa Mahmoud
Dr. Heba Hassan.

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

قرية رقم (٥) - الدور الأول - مبنى رقم (٩٣) - شارع النيل - محور كفر الدوار - الكورنيش - مصر
House No. (5) - First Floor-Building No. (93)- Nile Corniche - Mour El Dawar- Cairo
Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء حماده محمد حسانين	Request No.	: 13008882
Patient No.	: 28412222101621	Request Date	: 21/09/2023
Path No.	: 3208/23	Verification Date	: 07/10/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 38 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer (post NACT) .
Nature of the specimen: Leftt MRM

Gross Examination:
- Procedure: Left MRM

measured 19x18x3 cm with covering skin ellipse measured 18x10cm & attached axilla 8x5 cm .
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 1.8x1.5 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 2cm away from deep margin ,
- Lymph nodes number and size: 12 L.Ns up to 1x1 cm .

Microscopic examination:
- Histological type: No residual viable tumor tissue detected
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/12)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic Complete response

Diagnosis:
Left MRM (post NACT) :
No residual viable tumor tissue detected
- No DCIS
- Free margins
- Free retroareolar tissue
- Fat necrosis
- Free nipple and areola
- Free L.Ns (0/12)

Verified by :
Rana fathy

Room No. (4) - First Floor Building No. 987, Nile Corniche - Nile El Qadeem Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء حماده محمد حسانين	Request No.	: 13008882
Patient No.	: 28412222101621	Request Date	: 21/09/2023
Path No.	: 3208/23	Verification Date	: 07/10/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 38 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Pathologic Complete Response
- Stage : ypT0 , ypN0

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr.Menna Nabil

Verified by :
Rana fathy

Room No. (4) - First Floor Building No. 887- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Faith Islamic Center
C.T. - M.R.I
U.S. - Duppler - E.C.G. Stress
E.E.G - E.M.G - Mamm - Eye Unit

الجمعية الشرعية
مركز الفتح الإسلامى
أشعة مقطعية بالكمبيوتر - الرنين المغناطيسى
موجات صوتية - دوبلر ملون - رسم قلب بالمجهود
رسم مخ - رسم عضلات - فحص ثدى - وحدة عيون

اسم المريض : صفاء حماده التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٦

C.T. REPORT

Multislice CT scan examination was done for the Chest,Abdomen and Pelvis
Multiplanner reconstruction images were obtained *following* I.V. contrast enhancement and gut opacification with Telebrix

- *The liver is of normal size and regular outline, with no obvious focal mass lesion or dilated biliary radicle.*
- *The spleen, gall bladder and retroperitoneal structures including the kidneys, adrenal glands and pancreas are within normal limits, with no obvious mass lesion or significant lymph node enlargement.*
- *The opacified bowel loops including the stomach are regularly filled, with no obvious mass lesion or significant mural thickening.*
- *No ascites or pelvic collections seen.*
- *Normal C.T. appearance of the urinary bladder and uterus.*
- *Bilateral interstitial pulmonary reaction has been shown with prominent parenchymal vessels and bronchial wall thickening as well as fine reticulations.*
- *Otherwise, no other pulmonary abnormality could be detected.*
- *The pleural recesses are clear.*
- *The chest wall is preserved.*
- *No mediastinal mass lesion or gross lymphadenopathy could be detected.*

Impression:

- ***Bilateral mild interstitial pulmonary reaction has been shown .***
- ***Otherwise, un remarkable C.T. study of the abdomen and pelvis.***

YOURS SINCERELY,
Prof. Dr. Mohammed Fouad ,
PROF. OF RADIO-DIAGNOSIS
EL-AZHAR UNIVERSITY

شارع ١٠ بالمعادى ت : ٢٣٥٨٧٣٣٢ - ٢٣٥٨٥٨١٩ - ٠١١٠٠١٥١٣٨٠ - ٠١٠٢٨٤٨٣٦٩٥

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]